2.不完全脊髓损伤（损伤平面以下保留某些感觉和运动功能）

前脊髓综合征 由前向后发展,会累及到皮质脊髓束致运动出问题,薄束楔束也有可能累及	可致脊髓前中央动脉闭塞（最严重） 下肢瘫痪重于上肢 上肢的纤维靠内,离脊髓前中央动脉更近,故下肢缺血更严重	钱↓最严重
后脊髓综合征	运动、痛温觉（浅感觉）存在 而本体感觉（深感觉）障碍 精细触压觉也会障碍 （薄束楔束位于脊髓后索、其传导同侧深感觉）	本是同根生 后-深
脊髓中央管周围综合征 若对薄束楔束造成损害,在急性期时是类似于震荡,比较轻微,恢复期时可以恢复	多见于颈椎过伸损伤，急性期 没有感觉分离 恢复期时深感觉恢复了,但浅感觉没有恢复→恢复期有感觉分离 上肢瘫痪重于下肢（上肢神经元胞体靠近中央管）	中央-上级 不分离
脊髓半切综合征 （Brown-Sequard） 	同侧运动、本体感觉障碍 而对侧痛温觉障碍 （管运动的锥体束、管本体感觉的薄束楔束在脊髓不交叉，而管浅感觉的脊髓丘脑侧束在脊髓交叉 ttsx）	VS脊髓空洞症:慢性疾病,病变累及中央管前方,痛温觉会出问题,而深感觉没有出问题 一同运动感情深 对面感情浅

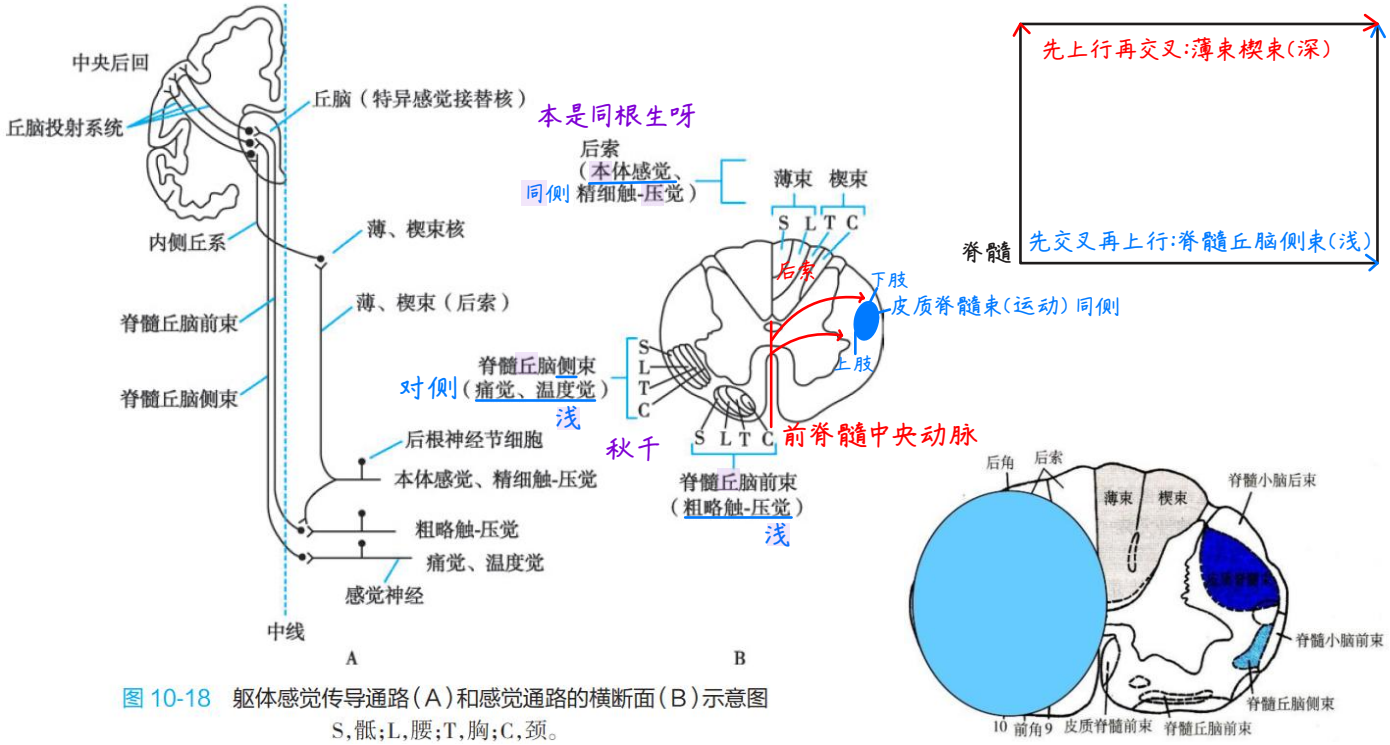


图 10-18　躯体感觉传导通路（A）和感觉通路的横断面（B）示意图
S,骶;L,腰;T,胸;C,颈。

3.完全脊髓损伤（损伤平面以下感觉、运动功能完全丧失）

（1）脊休克 2-4 周后软瘫变硬瘫（肌张力增高、腱反射亢进、病理征阳性）

（2）表现

C_1-C_4：四肢硬瘫

颈膨大 C_5-T_1：上肢软瘫、下肢硬瘫

T_2-L_1：上肢正常、下肢硬瘫

腰骶膨大 L_2-S_3：上肢正常、下肢软瘫

C1-C4
C5-T1（上肢）上肢软 ↑硬
T2-L1
L2-S3（下肢）正常 下肢软 ↑硬

